

Diverticule de l'urètre

WARWIKI

Information pour le patient · Une petite poche sur l'urètre qui collecte l'urine

Un diverticule de l'urètre est une petite **poche ou sac** qui se forme sur l'urètre — le tube qui évacue l'urine — presque toujours chez la femme. Un peu d'urine peut s'accumuler dans cette poche, entraînant des fuites, une gêne, des infections récurrentes ou des douleurs pendant les rapports. Il passe souvent inaperçu pendant des années, mais une fois reconnu, il se traite très bien.

À propos de cette affection

Les signes classiques sont les **“3 D”** :

- **Dribbling** — une petite quantité d'urine fuit juste après la miction
- **Dysurie** — brûlure ou gêne en urinant
- **Dyspareunie** — douleur pendant les rapports sexuels

D'autres signes incluent des **infections urinaires récurrentes**, une urgenturie ou des mictions fréquentes, ou encore une bosse sensible sur la paroi antérieure du vagin qui peut libérer du liquide à la pression.

Causes

On pense que la poche se forme lorsque de petites glandes autour de l'urètre se **bouchent et s'infectent**, puis se rompent dans l'urètre, laissant une cavité qui se remplit d'urine. Ce n'est pas un cancer et ce n'est causé par rien de ce que vous avez fait.

COMPRENDRE LES TERMES

Urètre

Le tube qui évacue l'urine hors du corps.

Diverticule

Une poche qui se forme sur un tube creux.

Les “3 D”

Dribbling, dysurie (brûlure) et dyspareunie (douleur pendant les rapports).

IRM

Le meilleur examen pour cartographier la poche avant la chirurgie.

Diverticulectomie

Ablation (excision) chirurgicale de la poche et réparation de l'urètre.

Lambeau de Martius

Un petit lambeau de tissu parfois utilisé pour renforcer la réparation.

Cystoscopie

Examen de l'intérieur de l'urètre et de la vessie avec une fine caméra.

AI-JE BESOIN D'UNE OPÉRATION ? Pas toujours. Une petite poche sans symptômes peut simplement être surveillée. Mais si elle provoque des fuites, des infections, des douleurs ou une gêne importante, l'ablation (diverticulectomie) est le traitement définitif. Votre chirurgien la cartographiera d'abord précisément par IRM.

Comment on le diagnostique

- Un examen clinique — une bosse sensible sur la paroi antérieure du vagin pouvant libérer du liquide à la pression
- Une **IRM**, qui est le meilleur moyen de visualiser la taille et la forme de la poche
- Parfois une **cystoscopie** pour voir l'orifice depuis l'intérieur

Comment on le traite

- 1 **Surveillance simple** pour une petite poche sans symptômes.
- 2 **Traiter les infections** présentes en premier lieu.
- 3 **Diverticulectomie** — ablation chirurgicale par voie vaginale de la poche et réparation soigneuse de l'urètre en plusieurs couches, parfois avec un lambeau de tissu.
- 4 Une **sonde** est laissée en place le temps de la cicatrisation, et une **radiographie de contrôle** est généralement réalisée avant son retrait.

Bon à savoir

- La réparation est délicate — une sonde sera en place pendant quelques semaines après l'opération.
- La plupart des patientes obtiennent un excellent soulagement ; parfois la poche peut récidiver ou une nouvelle fuite apparaît, ce qui peut être traité.
- La chirurgie est généralement planifiée une fois toute infection résolue.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre, des frissons ou une douleur pelvienne qui s'aggrave
- Une **impossibilité d'uriner** ou une sonde qui cesse de drainer (après l'opération)
- Un saignement important ou une fuite urinaire continue nouvelle

TROIS CHOSES À RETENIR

1. Un diverticule de l'urètre est une petite poche sur l'urètre — pensez aux "3 D" (fuites, brûlures, douleur pendant les rapports) et aux infections récidivantes.
2. L'IRM est l'examen de référence. Les petites poches sans symptômes sont surveillées ; les poches gênantes sont retirées par une réparation soigneuse.
3. Attendez-vous à une sonde et à une radiographie de contrôle après l'opération. Appelez en cas de fièvre, d'impossibilité d'uriner ou de fuite urinaire continue nouvelle.